

TEMA 2.10 • TRAUMATOLOGÍA

Fractura de Cadera

PERFIL EUNACOM 4.02.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **lesiones de partes blandas** constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencia y atención primaria. A diferencia de las **Fracturas: Generalidades**, estas afectan estructuras como músculos, ligamentos, tendones y tejido celular subcutáneo.

Contusiones

Una **contusión** es una lesión producida por un traumatismo directo (golpe) sobre las partes blandas, sin llegar a romper la continuidad de la piel.

- **Clínica:** Dolor local, aumento de volumen y aparición de **equimosis** (sangrado superficial).
- **Diagnóstico:** Es eminentemente clínico. El punto clave es la ausencia de signos de fractura.
- **Estudio:** Se solicita **radiografía** principalmente para descartar lesiones óseas si el mecanismo fue de alta energía o el dolor es muy invalidante.
- **Tratamiento:**
 1. Manejo del dolor con **AINES**.
 2. Crioterapia (frío local) en las primeras 48 horas, luego calor local.
 3. Reposo relativo. El pronóstico suele ser excelente en pocos días.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Desde el punto de vista médico-legal, una contusión simple es una lesión leve, pero si se asocia a una fractura, el cuadro pasa inmediatamente a ser una lesión grave.

Desgarros Musculares

El **desgarro muscular** es la rotura de fibras musculares debido a una elongación excesiva o una contracción brusca.

- **Mecanismo:** Suele ocurrir durante un ejercicio intenso o un estiramiento (elongación) forzado.
- **Clínica:** Dolor agudo (descrito a veces como un "tirón"), impotencia funcional y, frecuentemente, **equimosis** o hematoma secundario al sangrado de las fibras.
- **Diagnóstico:** Clínico. En caso de duda o para evaluar la extensión de la rotura, la **ecografía musculoesquelética** es el examen de elección.
- **Tratamiento:** Reposo del grupo muscular, AINES y aplicación de frío/calor. La regeneración muscular suele ser espontánea y efectiva.

Hematomas

Un **hematoma** es una colección de sangre en un espacio anatómico o dentro de un tejido, secundario a un traumatismo o un desgarro.

- **Clínica:** Aumento de volumen fluctuante, dolor y, en ocasiones, coloración violácea de la piel si la sangre se desplaza al tejido subcutáneo.
- **Diagnóstico:** Clínico, apoyado por **ecografía** para diferenciar entre una inflamación difusa y una colección líquida organizada.
- **Tratamiento:**
 - La mayoría son de manejo conservador (frío, calor, AINES).
 - **Cirugía de drenaje:** Indicada si el hematoma es muy grande, extremadamente doloroso o si presenta signos de **infección secundaria** (calor, rubor, fiebre).

Esguinces

El **esguince** es la lesión de los **ligamentos** (estructuras que unen hueso con hueso) tras un movimiento que supera los límites fisiológicos de la articulación.

Clasificación de los Esguinces

TABLA 2.10.1: GRADO VS LESIÓN ANATÓMICA

GRADO	LESIÓN ANATÓMICA	CLÍNICA PRINCIPAL
Grado 1	Estiramiento (distensión) sin rotura.	Dolor leve, poco o nada de aumento de volumen.
Grado 2	Rotura parcial de fibras.	Dolor moderado, aumento de volumen, equimosis .
Grado 3	Rotura total del ligamento.	Inestabilidad articular, dolor intenso, gran edema.

- **Diagnóstico:** Clínico. Se solicitan radiografías si hay sospecha de fractura asociada (por ejemplo, siguiendo las Reglas de Ottawa en el tobillo). La ecografía puede confirmar la rotura. - **Tratamiento Inicial (RICE):** - Reposo (Rest). - Ice (Hielo local). - Compresión (con vendaje elástico). - Elevación de la extremidad. - **Manejo Avanzado:** Los grados 2 y 3 pueden requerir inmovilización con órtesis removibles (bota walker, inmovilizador de rodilla) o yeso para favorecer la cicatrización. La cirugía se reserva para casos de inestabilidad crónica persistente.

Quiste de Baker (Quiste Poplíteo)

Es una distensión de la bursa asociada a la articulación de la rodilla, que se llena de **líquido sinovial**, formando una tumoración en la **fosa poplíteica**.

- **Clínica:** Aumento de volumen palpable y visible en la parte posterior de la rodilla. Suele ser asintomático a menos que crezca mucho o se rompa.
- **Rotura del Quiste de Baker:** Cuando se rompe, el líquido se desplaza hacia la pantorrilla, causando dolor agudo, edema y aumento de volumen.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El quiste de Baker roto es un gran simulador de la **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**. La clave diagnóstica es el antecedente de una masa previa en la zona poplíteica.

- **Tratamiento:** Observación y analgesia. Solo se punciona si es gigante y genera mucha molestia. La cirugía es excepcional.

Rotura del Tendón de Aquiles

Es una lesión grave, generalmente de etiología **degenerativa**, que afecta con mayor frecuencia a adultos de mediana edad que realizan actividad física esporádica.

- **Clínica:** Dolor súbito y muy intenso en la región posterior del tobillo, descrito como el "**signo del piedrazo**" o "latigazo" (el paciente siente que alguien lo golpeó o le lanzó una piedra).
- **Examen Físico:**
 - **Maniobra de Thompson:** Con el paciente en decúbito prono, se comprimen los gemelos (gastrocnemios). Lo normal es que se produzca una flexión plantar del pie. Si el tendón está roto, el pie no se mueve.
 - Se puede palpar un "hachazo" o brecha en el trayecto del tendón.
- **Diagnóstico:** Clínico, aunque se puede confirmar con ecografía o resonancia magnética.

NOTA CLÍNICA

La rotura del tendón de Aquiles ocurre más frecuentemente en pacientes con tendinopatía crónica previa, donde el tendón ha perdido su elasticidad normal.

- **Tratamiento:** Es una **urgencia quirúrgica**. Se debe reparar lo antes posible para evitar la retracción de los músculos gastrocnemios, lo que dificultaría enormemente la unión de los cabos del tendón en una cirugía tardía.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir un esguince de tobillo con una rotura de tendón de Aquiles. La incapacidad de realizar flexión plantar y la maniobra de Thompson positiva obligan a la derivación inmediata a traumatología.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un adulto mayor de setenta años con osteoporosis sufre una caída y no puede caminar. Al examen presenta abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fractura de Cadera. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La fractura de cadera en adulto mayor es por osteoporosis con caída a nivel y tiene una mortalidad a dos años del cincuenta por ciento.
- Se presenta con posición impúdica: abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad, más imposibilidad de levantar el talón.
- El tratamiento siempre es quirúrgico; las fracturas intertrocantericas se tratan con DHS; las de cuello con tornillo canulado.
- La prótesis de cadera se indica cuando se cumplen simultáneamente tres condiciones: fractura de cuello, desplazada, y mayor de sesenta y cinco años.
- La necrosis avascular de la cabeza femoral es la complicación más frecuente de la fractura de cuello femoral.
- La luxación posterior de cadera produce posición púdica: aducción, rotación interna y acortamiento; se trata con reducción cerrada.
- La cirugía de Girdlestone retira la cabeza femoral y se indica en pacientes postrados que se fracturan la cadera.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FRACTURA DE CADERA)

PREGUNTA 1

Un adulto mayor de setenta años con osteoporosis sufre una caída y no puede caminar. Al examen presenta abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?

- A) Luxación posterior de cadera; TAC de cadera
- B) Fractura de cadera; radiografía anteroposterior de cadera y pelvis
- C) Fractura de cadera; resonancia magnética de cadera
- D) Fractura de fémur; radiografía de fémur en dos proyecciones
- E) Coxartrosis aguda; radiografía de pelvis

PREGUNTA 2

Un paciente de setenta y dos años tiene una fractura de cuello femoral desplazada. ¿Cuál es el tratamiento?

- A) DHS o tornillo dinámico de cadera
- B) Prótesis de cadera
- C) Tornillo canulado y observar si hace necrosis
- D) Cirugía de Girdlestone
- E) Inmovilización y manejo conservador por la edad

PREGUNTA 3

Un copiloto tiene un accidente de tránsito frontal con golpe del tablero en la rodilla. Presenta imposibilidad de caminar con aducción y rotación interna de la cadera derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A) Fractura de cadera; osteosíntesis quirúrgica
- B) Luxación posterior de cadera; reducción cerrada bajo anestesia
- C) Fractura de fémur; radiografía y cirugía
- D) Luxación posterior de cadera; cirugía abierta de urgencia
- E) Luxación anterior de cadera; reducción cerrada

RESUMEN: FRACTURA DE CADERA

La fractura de cadera es una fractura osteoporótica frecuente en adultos mayores con una mortalidad a dos años cercana al cincuenta por ciento. Su mecanismo en el adulto mayor es una caída a nivel simple. Se presenta con imposibilidad de caminar, imposibilidad de despegar el talón del suelo y la posición impúdica: abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad. El diagnóstico se hace con radiografía anteroposterior y axial de cadera más anteroposterior de pelvis para comparar ambas caderas. El tratamiento es siempre quirúrgico, pero se debe estabilizar primero si el paciente está en mal estado general. La decisión quirúrgica depende de la localización de la fractura. Las fracturas intertrocantericas se tratan con osteosíntesis con DHS o Dynamic Hip Screw, tornillo dinámico de cadera. Las fracturas de cuello femoral se tratan con tornillo canulado si el paciente es menor de sesenta y cinco años o si la fractura no está desplazada. Se coloca prótesis de cadera cuando se cumplen tres condiciones simultáneamente: fractura de cuello femoral, más desplazada, más paciente mayor de sesenta y cinco años. Esta indicación existe porque la fractura de cuello desplazada tiene alto riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral, y si ya hay necrosis o si el riesgo es muy alto se prefiere la prótesis. La luxación posterior de cadera tiene la posición púdica que es lo contrario de la impúdica: aducción, rotación interna y acortamiento. Se produce en accidentes de tránsito cuando el tablero golpea la rodilla del copiloto empujando la cadera hacia atrás. El tratamiento es reducción cerrada bajo anestesia. Siempre hay que evaluar el nervio ciático porque se puede lesionar en esta luxación. La cirugía de Girdlestone retira la cabeza femoral y está indicada en pacientes postrados que se fracturan la cadera.